1. Nguy cơ tự sát

Page 1:

"Bạn có ý định tự sát không?" ->Yes or No

- **Nếu chọn "Có"**

Luôn có sự hỗ trợ dành cho bạn.

Liên hệ miễn phí và bảo mật ngay lập tức (chuyển qua số đt khẩn cấp luôn)

Tìm hiểu về dịch vụ DDNNM (chuyển hướng sang Đường dây nóng Ngày mai)
Lịch làm việc 13:00 - 20:30 (Thứ Tư đến Chủ nhật hàng tuần)

- Trang chủ: Đường dây nóng Ngày mai hoặc Fanpage chính thức. [1, 2]

- **Nếu chọn "Không"**

Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Chào mừng bạn đến MÈO! (chuyển hướng về trang chủ sau 5 giây)

2. Thân chủ (Client)

Thân chủ: người sử dụng dịch vụ tham vấn/trị liệu và chủ động tham gia vào quá trình thay đổi, không chỉ là "bệnh nhân" thụ động.

Thân chủ có thể tìm đến vì:

- Khó khăn cảm xúc.
- Mâu thuẫn trong mối quan hệ.
- Khủng hoảng cuộc sống.
- Trầm cảm, lo âu hoặc sang chấn.
- Khó đưa ra quyết định.
- Muốn hiểu rõ bản thân.
- Muốn cải thiện quan hệ và chất lượng sống.

3. Phân biệt nhà tham vấn, nhà trị liệu, nhà tâm lý và bác sĩ tâm thần

Chia thành 4 pillar trên màn hình

Nhà tham vấn (counselor):là chuyên viên được đào tạo để hỗ trợ thân chủ gặp khó khăn về mặt cảm xúc, các mối quan hệ, thích nghi, v.v.

Phạm vi đào tạo và chuyên môn của từng nhà tham vấn có thể khác nhau.

Nhà trị liệu (therapist): là một thuật ngữ bao quát, dùng để chỉ chuyên gia cung cấp hỗ trợ trị liệu, bao gồm counselor (chuyên viên tham vấn), psychologist (nhà tâm lý học), psychotherapist (nhà trị liệu tâm lý),...

Cần hỏi về nền tảng chuyên môn, quá trình đào tạo và đăng ký hành nghề của người đó để hiểu rõ mình đang làm việc với ai và có thể kỳ vọng điều gì.

Nhà tâm lý lâm sàng (Clinical Psychologist):

là chuyên viên tâm lý được đào tạo về mặt lâm sàng.
có thể đánh giá, chẩn đoán và thực hành các liệu pháp trị liệu.
có thể thực hành trị liệu cá nhân, cặp đôi hay hệ thống gia đình.

Bác sĩ tâm thần (Psychiatrist):

là bác sĩ y khoa đã được đào tạo chuyên sâu về sức khỏe tâm thần.
Được quyền kê thuốc để điều trị các bệnh tâm thần.
Vai trò chẩn đoán và quản lý các vấn đề sức khỏe tâm thần dưới góc độ y khoa.
Việc gặp bác sĩ tâm thần là cần thiết khi thuốc là một phần quan trọng của quá trình điều trị.

-> Nhà tâm lý lâm sàng và chuyên viên tham vấn cũng có thể phối hợp làm việc cùng bác sĩ tâm thần như một phần của đội ngũ chăm sóc cho bệnh nhân.

Tâm lý gia tập sự có hướng dẫn

ĐIỀU GÌ DIỄN RA TRONG PHÒNG THAM VẤN?

(^ này là tựa đề chính rồi hiện ra và link đến 4 mục ở dưới đây)

4. Nhà tham vấn sẽ làm gì?

Khi tiếp nhận ca và trong những phiên đầu tiên, nhà tham vấn thường sẽ trao đổi với thân chủ về những nội dung như:

- Vai trò của từng bên, chi phí, thời lượng và cách làm việc.
- Giải thích nguyên tắc bảo mật và giới hạn của bảo mật trong tham vấn tâm lý.
- Lý do thân chủ đến tham vấn và những thông tin liên quan đến tình trạng sức khoẻ của thân chủ như cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, các mối quan hệ và hoàn cảnh sống.
- Đánh giá mức độ an toàn, đặc biệt khi nhà tham vấn nhận thấy thân chủ có nguy cơ tự hại hay tự sát.
- Cùng thân chủ thống nhất mục tiêu làm việc và lên kế hoạch.

Trong phiên tham vấn, nhà tham vấn sẽ lắng nghe thân chủ và phản hồi hay đặt câu hỏi khi cần thiết để giúp thân chủ làm rõ cảm xúc và nhu cầu của bản thân. Ngoài ra, nhà tham vấn còn có thể giúp thân chủ xây dựng những kỹ năng như điều tiết cảm xúc, giao tiếp, nhận diện những vòng lặp về suy nghĩ - cảm xúc - hành vi, v.v. và đưa ra những bài tập thực hành để thân chủ có thể tự luyện tập giữa các phiên và dần trở nên tự chủ hơn khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Khi cần thiết, nhà tham vấn cũng có thể làm việc với gia đình và các bên liên quan để thân chủ nhận được sự hỗ trợ một cách toàn diện hơn bên ngoài phòng tham vấn

Xuyên suốt quá trình làm việc, nhà tham vấn sẽ theo dõi tiến triển và trao đổi với thân chủ để điều chỉnh kế hoạch nếu cần hoặc đề xuất chuyển ca khi nhận thấy tình trạng của thân chủ vượt quá năng lực chuyên môn của mình, nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của thân chủ khi sử dụng dịch vụ.

Nhà tham vấn KHÔNG làm gì?

Một nhà tham vấn thực hành có năng lực chuyên môn và đạo đức sẽ không thực hiện những điều sau:

- KHÔNG quyết định thay cho thân chủ.
    - Quyền tự quyết của thân chủ cần được tôn trọng, trừ khi nhà tham vấn nhận thấy thân chủ có nguy cơ gây hại cho bản thân hay người khác.
- KHÔNG ép thân chủ làm theo quan điểm cá nhân của nhà tham vấn.
    - Cần tôn trọng quan điểm của thân chủ, ngay cả khi nhà tham vấn không đồng tình với điều đó.
- KHÔNG hứa chắc chắn chữa khỏi.
    - Nhà tham vấn cần rõ ràng và minh bạch về phác đồ điều trị và mục tiêu làm việc với thân chủ.
- KHÔNG xúc phạm, đe dọa hoặc làm nhục thân chủ.
- KHÔNG có quan hệ tình cảm, tình dục hoặc tài chính với thân chủ.
    - Mối quan hệ giữa nhà tham vấn và thân chủ là mối quan hệ trị liệu; nếu xuất hiện thêm một mối quan hệ khác sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình trị liệu.
- KHÔNG dùng câu chuyện của thân chủ để quảng cáo khi chưa được sự đồng thuận từ phía thân chủ.

    - Ưu tiên hàng đầu của nhà tham vấn và các dịch vụ tham vấn nói chung nên là việc bảo mật thông tin của thân chủ.

5. Quyền của thân chủ

Thân chủ có quyền:

- Được tôn trọng và không bị kỳ thị bất kể họ là ai.
- Được biết bằng cấp, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của nhà tham vấn.
- Được giải thích về các liệu pháp, chi phí và thời lượng tham vấn.
- Được biết thông tin cá nhân được lưu trữ và bảo mật thế nào.
- Được biết những trường hợp bảo mật có nguy cơ bị phá vỡ.
- Được đặt câu hỏi về tiến trình trị liệu.
- Được từ chối thực hiện một liệu pháp, hoạt động hay bài tập.
- Được xin ý kiến chuyên gia khác.
- Được đổi chuyên gia hoặc ngừng trị liệu.
- Được biết cách phản ánh hoặc khiếu nại.

6. Bảo mật (Confidentiality) và giới hạn bảo mật

Bảo mật là một trong những nguyên tắc nền tảng của tham vấn tâm lý. Những thông tin được thân chủ chia sẻ trong quá trình trị liệu sẽ không được tiết lộ, trừ khi có sự cho phép của thân chủ.

Những trường hợp mà nhà tham vấn có thể phải chia sẻ thông tin và phá vỡ bảo mật bao gồm:

- Thân chủ có nguy cơ gây hại đối với bản thân.
- Có nguy cơ gây hại đối với người khác.
- Có yêu cầu hợp pháp từ cơ quan có thẩm quyền.
- Cần trao đổi với ekip giám sát chuyên môn.

7. CÁCH NHẬN BIẾT NHÀ CHUYÊN MÔN UY TÍN

Những điểm nên kiểm tra

- Danh tính và cơ sở làm việc rõ ràng.
- Bằng cấp có uy tín.
- Được đào tạo đúng liệu pháp đang thực hành.
- Có kinh nghiệm với vấn đề và nhóm tuổi của thân chủ.
- Có giấy phép hoặc đăng ký hành nghề khi pháp luật yêu cầu.
- Giải thích rõ chi phí, lịch hẹn và chính sách hủy buổi.
- Có thỏa thuận bảo mật.

- Biết giới hạn năng lực chuyên môn và sẵn sàng chuyển ca.
- Không hứa chữa khỏi chắc chắn.
- Theo dõi tiến triển và tiếp nhận phản hồi.
- Tôn trọng văn hóa, tôn giáo, giới và xu hướng tính dục.
- Công khai việc được giám sát trong thực hành.

Những câu nên hỏi trước khi bắt đầu

Đây là một số câu hỏi chúng mình đề xuất để

- Anh/chị được đào tạo và hành nghề với tư cách nào?
- Anh/chị có kinh nghiệm với vấn đề của tôi không?
- Phương pháp dự kiến là gì?
- Phương pháp này có lợi ích và giới hạn nào?
- Bao lâu sẽ đánh giá lại tiến triển?
- Bảo mật được áp dụng thế nào?
- Trong trường hợp nào thông tin có thể phải được chia sẻ?
- Nếu có khủng hoảng ngoài giờ, tôi cần làm gì?
- Nếu anh/chị đang thực tập, ai là người giám sát?

Dấu hiệu cảnh báo về người hành nghề

- Hứa chữa khỏi 100%.
- Chẩn đoán qua vài tin nhắn hoặc bình luận.
- Dùng một phương pháp cho tất cả mọi người.
- Khuyên tự ý ngưng thuốc.
- Né tránh câu hỏi về bằng cấp.
- Không giải thích bảo mật.
- Làm nhục, đe dọa hoặc ép buộc.
- Có hành vi tình dục hoặc tài chính với thân chủ.
- Ép thân chủ mua sản phẩm.
- Yêu cầu giữ bí mật về hành vi của chuyên gia.
- Đổ lỗi cho nạn nhân.
- Kỳ thị cộng đồng LGBTQIA+ hoặc thực hiện “trị liệu chuyển đổi”.
- Không có phương án xử lý tự sát, tự hại hoặc khủng hoảng.

> Nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin tham khảo, không thay thế việc đánh giá, chẩn đoán hoặc điều trị của chuyên gia sức khỏe tâm thần có đủ năng lực.

Các rối loạn tâm thần

cấu trúc trình bày: tóm tắt đặc điểm + một số rối loạn thuộc nhóm đó

(list ở đây là dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-5-TR)

- Rối loạn phát triển thần kinh (Neurodevelopmental Disorders)

    - Đây là nhóm rối loạn thường xuất hiện sớm, trước khi trẻ bắt đầu đi học, do những sự khác biệt về não bộ dẫn đến những khó khăn trong giao tiếp, tương tác xã hội, học tập, nghề nghiệp, v.v.
    - hệ quả:
    - ví dụ: ASD, ADHD

- Rối loạn phổ tâm thần phân liệt và các rối loạn loạn thần khác (Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders)
- Rối loạn lưỡng cực và các rối loạn liên quan (Bipolar and Related Disorders)
- Rối loạn trầm cảm (Depressive Disorders)
- Rối loạn lo âu (Anxiety Disorders)
- Obsessive-Compulsive and Related Disorders
- Trauma- and Stressor-Related Disorders
- Dissociative Disorders
- Somatic Symptom and Related Disorders
- Feeding and Eating Disorders
- Elimination Disorders
- Sleep-Wake Disorders
- Sexual Dysfunctions
- Gender Dysphoria
- Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders
- Substance-Related and Addictive Disorders
- Neurocognitive Disorders
- Personality Disorders
- Paraphilic Disorders
- Other Mental Disorders and Additional Codes
- Medication-Induced Movement Disorders and Other Adverse Effects of
- Medication
- Other Conditions That May Be a Focus of Clinical Attention